

تطبيق UberTib

دراسة تقنية

فهرس المحتويات

الصفحة

3	1- الملخص التنفيذي
4	2- وصف فكرة التطبيق
4	3- المشكلة التي يحلها التطبيق
5	4- القيمة التي يقدمها التطبيق
5	5- السوق المستهدف
6	6- تحليل السوق والفرصة
7	7- المنافسون والبدائل الحالية
7	8- نموذج العمل والربح
9	9- آلية الدفع والتسوية المالية
11	10- مزايا التطبيق ووظائفه بحسب جهة الاستخدام
11	11- نظام تقييم الأطباء
12	12- الخطة التقنية
13	13- الدراسة القانونية والتنظيمية
16	14- مراحل تنفيذ المشروع
17	15- الجدول الزمني لمراحل المشروع
18	16- الكادر البشري المطلوب
18	17- الخطة التسويقية الأولية
20	21- التوصية النهائية

دراسة تقنية

لتطبيق UberTib الطبي

1- الملخص التنفيذي

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم جدوى إطلاق تطبيق هواتف محمولة متخصص في ربط المرضى بأطباء الأسنان داخل سوريا، على أن يبدأ المشروع من مدينة حلب كمرحلة أولى، ثم يتوسع لاحقاً إلى باقي المدن السورية. يقوم التطبيق على فكرة إنشاء منصة رقمية موثوقة تتيح للمريض البحث عن طبيب الأسنان الأنسب، المقارنة بين الأطباء، الاطلاع على بياناتهم، معرفة موقع العيادة والخدمات والأسعار التقريبية، حجز الموعد، الدفع الإلكتروني داخل التطبيق، ثم تقييم التجربة بعد الزيارة، كما يعتبر التطبيق منصة تقييم شاملة للأطباء وفق أسس علمية وعملية. أما بالنسبة لأطباء الأسنان، فيتيح لهم التطبيق إنشاء حسابات خاصة بهم، عرض بياناتهم المهنية وخدماتهم، استقبال الحجوزات، إدارة المواعيد، متابعة الدفعات، وبناء حضور رقمي موثوق داخل سوق محلي يحتاج إلى تنظيم وثقة. سيعتمد التطبيق على اشتراك شهري أو سنوي من الأطباء، وذلك بهدف ضمان الجدية والمصداقية والتعاون الكامل من طرف الأطباء، وبناء قاعدة بيانات قوية، وتحقيق انتشار أفقي داخل مدينة حلب كمرحلة أولى. يبدأ المشروع من قطاع طب الأسنان، لكن من الأفضل أن يبقى الاسم التجاري عاماً بما يسمح بالتوسع لاحقاً نحو خدمات التجميل والخدمات الطبية الاختيارية، دون أن يضعف ذلك تركيز المرحلة الأولى، حيث يجب أن تبقى السنة الأولى مخصصة لبناء منصة موثوقة في طب الأسنان تقوم على الجودة، التوثيق، والضمان. يمثل المشروع فرصة واعدة، لكنه يتطلب إدارة دقيقة للجوانب القانونية، المالية، التقنية، والتشغيلية، خاصة بسبب حساسية القطاع الصحي، طبيعة تقييم الأطباء، وضرورة تنظيم المدفوعات الإلكترونية والتحويلات المالية بطريقة واضحة ومتوافقة مع الأنظمة المحلية.

الخلاصة التنفيذية	البند
منصة تصنيف جودة وتسعير وضمان مشروط لخدمات طب الأسنان، لا مجرد تطبيق حجز. تبدأ بالأسنان ثم تؤسس لاحقاً للتوسع إلى التجميل والخدمات الطبية الاختيارية.	جوهر المشروع
نقل ثقافة المريض من الاعتماد على العلاقات والسمعة الاجتماعية إلى الاعتماد على التوثيق العلمي: صور، أشعة ذروية رقمية، صور قبل/بعد، وخطة علاج واضحة.	الفكرة الأصلية
الطبيب الذي لا يملك جهاز أشعة ذروية رقمي داخل عيادته يصنف داخلياً F، ولا يتمتع بضمان المنصة أو التسعير المرتفع. الأشعة البانورامية أو CBCT الخارجية لا تعوض غياب الأشعة الذروية الرقمية داخل العيادة.	قاعدة غير قابلة للنقاش
لا يوجد راتب لطبيب أسنان مراجع في المرحلة الأولى. Professor Sam Wise يحكم في المنازعات الكبيرة والملفات السريرية الحساسة دون تحميل المشروع راتب طبيب مستقل في البداية.	المؤسس السريري

2- وصف فكرة التطبيق

التطبيق عبارة عن منصة رقمية متخصصة في طب الأسنان، تعمل كوسيط بين ثلاثة أطراف رئيسية:

1. المريض.

2. طبيب الأسنان أو العيادة.

3. إدارة التطبيق.

يستطيع المريض من خلال التطبيق اختيار الطبيب بناءً على عدة معايير، أهمها:

- قرب العيادة من موقعه.
- اختصاص الطبيب أو نوع الخدمة.
- توفر المواعيد.
- مستوى توثيق حساب الطبيب.
- السعر التقريبي أو قيمة المعالجة.
- صور العيادة وتجهيزاتها.
- تقييمات المرضى السابقين.
- خبرة الطبيب ومؤهلاته المعلنة.

أما الطبيب، فيستطيع إنشاء حساب، وإدخال بياناته المهنية، وتحديد خدماته وأسعاره التقريبية ومواعيده المتاحة، ثم استقبال الحجوزات والدفعات من خلال التطبيق. تُلغى هذه النسخة الافتراض السابق بضرورة وجود طبيب أسنان أو مراجع جودة سريرية مستقلة في المرحلة الأولى، إذ إن هذا الدور غير مطلوب شهرياً في بداية المشروع، وقد يتحول إلى عبء تشغيلي مبكر لا حاجة له قبل اتساع حجم الحالات. ويمكن إعادة إدخاله لاحقاً عند الحاجة، خلال فترة تتراوح بين شهر و12 شهراً بحسب نمو المنصة وكثافة الاستخدام. كما تفترض النسخة أن العلاقة التشغيلية في البداية ستكون محصورة بين المنصة والأطباء والمرضى، دون شراكات مباشرة مع مراكز الأشعة أو الموردين. ويمكن للطبيب إحالة المريض خارجياً لإجراء الصور الشعاعية اللازمة مثل البانوراما أو CBCT، بينما لا يشكّل عدم توفر جهاز أشعة رقمية داخل العيادة عائقاً للتصنيف، لكنه يعني أن الخدمات التي تحتاج توثيقاً شعاعياً أساسياً تُصنّف داخلياً ضمن الفئة F. والهدف من هذه القاعدة ليس الانتقاص من أي طبيب أو عيادة، بل حماية المشروع وضمان جودة الخدمة؛ إذ لا يمكن بناء منصة طبية موثوقة إذا لم يكن الطبيب قادراً على توثيق الحالة رقمياً وبطريقة قابلة للمرجعة داخل عيادته.

3- المشكلة التي يحلها التطبيق

يعاني سوق خدمات طب الأسنان في سوريا عموماً، وفي حلب خصوصاً، من عدة مشاكل عملية:

3.1 مشاكل المرضى

- صعوبة معرفة الطبيب المناسب.
- الاعتماد الكبير على توصيات الأصدقاء والمعارف.
- غياب منصة موحدة تجمع الأطباء حسب المنطقة والخدمة.
- صعوبة معرفة الأسعار التقريبية قبل الذهاب إلى العيادة.
- عدم وضوح المواعيد أو صعوبة الحجز.
- ضعف الثقة بالتقييمات المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعي.
- عدم وجود سجل رقمي واضح لتجربة المرضى مع الطبيب.
- صعوبة المقارنة بين عدة أطباء بشكل منظم.

3.2 مشاكل أطباء الأسنان

- ضعف الظهور الرقمي المنظم لدى كثير من الأطباء.

- اعتماد جزء كبير من التسويق على العلاقات الشخصية أو صفحات فيسبوك.
- عدم وجود منصة متخصصة تجمع المرضى الباحثين فعلاً عن خدمة أسنان.
- صعوبة إدارة الحجوزات رقمياً لدى بعض العيادات.
- ضياع فرص كثيرة بسبب عدم وضوح المواعيد أو ضعف التواصل.
- عدم وجود قناة دفع إلكتروني منظمة مرتبطة بالحجز.

3.3 مشاكل السوق ككل

- عشوائية المعلومات.
- ضعف التوثيق.
- غياب معيار واضح للمقارنة.
- انتشار الإعلانات غير المنظمة.
- عدم وجود تجربة رقمية متكاملة من البحث حتى الدفع والتقييم.

4- القيمة التي يقدمها التطبيق

4.1 للمريض

يمنح التطبيق المريض تجربة أسهل وأكثر ثقة، حيث يستطيع أن يجد طبيباً مناسباً دون الاعتماد الكامل على التخمين أو السؤال العشوائي. كما يتيح له معرفة معلومات واضحة قبل الحجز، والدفع إلكترونياً، وتقييم التجربة بعد الزيارة.

4.2 للطبيب

يمنح التطبيق الطبيب قناة احترافية وموثوقة للظهور والحصول على حجوزات، مع إمكانية بناء سمعة رقمية مبنية على الالتزام والتجربة، لا على الإعلانات فقط.

4.3 لإدارة التطبيق

يخلق التطبيق نموذج ربح قائم على كل عملية حجز أو دفع ناجحة، مما يجعل نمو إيرادات التطبيق مرتبطاً مباشرة بنمو استخدامه وانتشاره.

5- السوق المستهدف

5.1 السوق الجغرافي الأولي

المرحلة الأولى ستكون في مدينة حلب فقط، وذلك للأسباب التالية:

- حلب مدينة كبيرة وكثيفة سكانياً.
- وجود طلب فعلي على خدمات طب الأسنان.
- سهولة حصر الأطباء ميدانياً مقارنة بإطلاق وطني مباشر.
- إمكانية اختبار النموذج في سوق حقيقي قبل التوسع.
- وجود فرصة لبناء علامة محلية قوية ثم التوسع منها.
- وجود فرع رسمي مرخص للجهة المنفذة للمشروع (مؤسسة أفق) داخل مدينة حلب، مع فريق تنفيذي قوي.

5.2 الجمهور المستهدف من المرضى

- سكان مدينة حلب (بشكل أولي).
- الشباب والموظفون الذين يستخدمون الهواتف الذكية.
- العائلات الباحثة عن طبيب موثوق لأطفالها أو أفرادها.
- المرضى الباحثون عن أسعار واضحة أو خيارات متعددة.
- المغتربون الذين يريدون حجز مواعيد لأهاليهم داخل سوريا.
- السياح (وخاصة من دول الخليج العربي).
- المستخدمون الذين يفضلون الدفع الإلكتروني والتنظيم الرقمي.

5.3 الجمهور المستهدف من الأطباء

- أطباء الأسنان العامون.
- اختصاصيو التقويم.
- اختصاصيو جراحة الفم والفكين.
- أطباء تجميل الأسنان.
- أطباء زراعة الأسنان.
- عيادات ومراكز طب الأسنان.
- أطباء شباب يبحثون عن انتشار.
- أطباء معروفون يريدون تنظيم حجوزاتهم رقمياً.

6- تحليل السوق والفرصة

يعتمد المشروع على وجود فجوة واضحة بين حاجة المرضى إلى الثقة والتنظيم، وبين الطريقة التقليدية الحالية في اختيار الطبيب. في السوق السوري، لا تزال قطاعات كثيرة تعمل عبر العلاقات الشخصية وصفحات التواصل، وهذا يخلق فرصة لتطبيق متخصص يقدم تجربة منظمة وموثقة. لكن من المهم عدم التعامل مع السوق كأنه جاهز بالكامل للتطبيقات المتقدمة منذ اليوم الأول. يجب بناء الثقة تدريجياً عبر:

- أطباء موثقين فعلاً.
 - حملات ميدانية ورقمية.
 - تجربة استخدام سهلة.
 - عدم المبالغة في الوعود الطبية.
 - دعم عملاء سريع.
 - عرض أسعار وخدمات بطريقة شفافة.
 - سياسة دفع واسترداد واضحة.
 - نظام تقييم واضح ومنصف للأطباء.
- فرصة المشروع لا تكمن فقط في حجز المواعيد، بل في امتلاك قاعدة بيانات منظمة لسوق طب الأسنان، وربطها بالدفع الإلكتروني، والتقييمات، والتحليلات، والتوسع لاحقاً إلى اختصاصات طبية أخرى. تمتلك الفكرة فرصة حقيقية في السوق السوري، لكنها ليست فرصة سهلة أو مضمونة؛ فالسوق منخفض الدخل، سريع التغير، ويتأثر بعودة تدريجية للمغتربين وبنشوء استثمارات جديدة. لذلك يجب بناء النموذج على فهم واضح لتفاوت القدرة الشرائية بين فئتين أساسيتين: فئة محلية تبحث عن خدمة موثوقة بسعر مناسب، وفئة من المغتربين أو الزوار تبحث عن جودة طبية موثقة بتكلفة أقل من أوروبا أو دول الخليج.

المؤشر	الدلالة العملية للمشروع
استخدام الإنترنت	مصادر رقمية مثل DataReportal تقدر مستخدمي الإنترنت في سوريا بنحو 9.25 مليون بنهاية 2025 مع اختراق 35.8%. هذا يعني أن التسويق الرقمي ضروري لكنه غير كافٍ وحده.
عودة السوريين	تقارير UNHCR تذكر عودة نحو 1.3 مليون سوري من الخارج خلال 2025 رغم هشاشة الخدمات. هذه الشريحة قد تزيد الطلب على العلاج الخاص والجودة الموثقة.
التعافي الاقتصادي	البنك الدولي يتحدث عن بوادر تعافٍ مرتبطة بتخفيف العقوبات وعودة اللاجئين والاستثمار، لكن النمو سيظل حذراً ومتفاوتاً.
الرواتب المحلية	الرواتب العامة المنشورة تدور غالباً حول 100-150 دولار في القطاع العام، وبعض العقود الجديدة أو الوظائف الخاصة قد تبدأ من 300 دولار؛ لذلك راتب 300 دولار لموظف تشغيل محلي جيد واقعي، و500 دولار يجب أن يكون للوظائف القوية فقط.

7- المنافسون والبدائل الحالية

لا يشترط أن يكون المنافس تطبيقاً مشابهاً تماماً. في هذا المشروع، المنافسون الحقيقيون هم البدائل التي يستخدمها المريض حالياً.

7.1 البدائل الحالية

- سؤال الأقارب والأصدقاء.
- صفحات أطباء الأسنان على فيسبوك.
- مجموعات فيسبوك المحلية.
- إعلانات ممولة فردية للأطباء.
- توصيات واتساب.
- خرائط غوغل.
- الذهاب المباشر إلى العيادات المعروفة.
- الاعتماد على طبيب محدد للعائلة.

7.2 نقاط ضعف البدائل الحالية

- المعلومات متناثرة.
- لا توجد مقارنة منظمة.
- لا توجد آلية دفع موحدة.
- لا توجد تقييمات موثقة بعد الزيارة.
- لا توجد سياسة إلغاء أو استرداد.
- لا توجد درجة موثوقية واضحة للطبيب.
- لا توجد لوحة إدارة للحجز من طرف الطبيب.
- لا توجد تجربة موحدة للمريض.

7.3 الميزة التنافسية للتطبيق

- تخصص كامل في طب الأسنان.
- بدء محلي مركز من حلب.
- تسجيل موثوق للأطباء.
- توثيق بيانات الطبيب.
- دفع إلكتروني داخل التطبيق.
- تقييم بعد الزيارة فقط.
- تسوية مالية منظمة.
- إمكانية التوسع الجغرافي والقطاعي لاحقاً.

8- نموذج العمل والربح

يعتمد نموذج العمل على قاعدة أساسية: تسجيل مأجور للأطباء، ونسبة تأتي من كل عملية دفع تتم داخل التطبيق.

8.1 العمولة الأساسية

لتقليل احتمالات التحايل، يجب ألا تكون عمولة التطبيق مرتفعة لدرجة تدفع الطبيب إلى تحويل المريض خارج المنصة. والأفضل اعتماد نموذج متوازن يقوم على عمولة منخفضة نسبياً، مع اشتراك شهري تدريجي، ومساهمة ضمان منفصلة للحالات التي تشملها الحماية. بهذا الشكل، يدرك الطبيب أن تحويل الحالة خارج التطبيق قد يوفر له نسبة محدودة فقط، لكنه في المقابل يخسر مزايا أهم مثل التصنيف، الضمان، الظهور داخل المنصة، وقناة الثقة مع المرضى. كما يمكن منح أول 300 طبيب خطة تأسيسية باسم Founding Doctor تتضمن إعفاءً مؤقتاً من الاشتراك خلال مرحلة الإطلاق، دون تقديم وعد بإعفاء دائم. ويحق للمنصة مراجعة هذا الإعفاء لاحقاً عند وصولها إلى قوة سوقية واضحة، مثل تحقيق 1000 حجز مدفوع شهرياً، أو 5000 مستخدم نشط، أو مرور 12 إلى 18 شهراً على الإطلاق.

الفئة	عمولة المنصة المقترحة	اشتراك شهري لاحق	مساهمة ضمان
A	7-8%	20-30 دولار	6-8% للحالات الكبيرة المشمولة
B	8%	15-20 دولار	4-6%
C	8-9%	10-15 دولار	2-4%
D	9-10%	5-10 دولار	1-2%
F	8-10% حجز/إدارة فقط	0-5 دولار	0%

8.2 أنواع الدفعات داخل التطبيق

يمكن أن تكون الدفعات على عدة مستويات:

1. رسوم حجز موعد.
2. رسوم معاينة أولية.
3. اشتراكات الأطباء.
4. تكلفة خدمة علاجية محددة بعد التشخيص.
5. باقات علاجية لاحقاً، مثل تقويم أو زراعة أو تبييض.

8.3 مصادر دخل إضافية مستقبلية

مع بقاء التسجيل الأساسي للأطباء مأجوراً، يمكن لاحقاً إضافة مصادر دخل اختيارية، مثل:

- ظهور مميز للطبيب داخل نتائج البحث.
- باقات ترويجية داخل التطبيق.
- إعلانات طبية منضبطة وغير مضللة.
- تقارير أداء مدفوعة للأطباء.
- اشتراكات مراكز الأسنان الكبيرة في أدوات إدارة متقدمة.
- شراكات مع مخابر أسنان أو شركات مستلزمات طبية.
- اعتماد باقات علاجية وخدمات متقدمة مدفوعة بالكامل عبر التطبيق.
- نظام اشتراكات للمرضى محدد بحسب كل طبيب.

لكن يجب عدم إدخال هذه المصادر مبكراً بطريقة تضعف ثقة المستخدمين أو تجعل نتائج البحث تبدو مدفوعة بالكامل، بل يتم إدخالها ضمن الخدمات تدريجياً بحسب خطة كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع.

9- آلية الدفع والتسوية المالية

9.1 مبدأ الدفع

يعتمد التطبيق على الدفع الإلكتروني بالكامل داخل التطبيق، باستخدام منصة ShamCash أو أي مزود دفع إلكتروني محلي آخر متاح وموثوق، كما أن الدفع عبر بطاقات فيزا و ماستر كارد قد بدأ تدريجياً بالتطبيق داخل سوريا.

9.2 نموذج التحصيل المركزي

النموذج المقترح في المرحلة الأولى هو التحصيل المركزي، أي:

1. يدفع المريض داخل التطبيق.
2. يدخل المبلغ إلى حساب المنصة التجاري.
3. يسجل النظام العملية داخلياً.
4. يتم اقتطاع عمولة التطبيق.
5. تظهر حصة الطبيب داخل رصيده في لوحة التحكم.
6. تبقى الحصة معلقة حتى إتمام الموعد.
7. بعد تأكيد الموعد وانتهاء فترة الاعتراض، تصبح الحصة قابلة للتحويل.
8. يتم تحويل المستحقات للطبيب وفق دورة تسوية دورية (شهرية أو أسبوعية).
9. يمثل الدفع داخل التطبيق عنصراً أساسياً في ضمان جودة الخدمة، وضبط التصنيف، والحد من محاولات التحايل.
10. الخدمات العلاجية الكبيرة، لا يتم تحويل كامل مستحقات الطبيب فوراً، بل يمكن حجز جزء منها لفترة محددة قد تصل إلى ستة أشهر، بهدف التأكد من اكتمال التوثيق الطبي، وعدم ظهور فشل مبكر في العلاج، أو ورود شكاوى جديدة من المريض.

9.3 تقرير دورة التسوية

في نهاية كل دورة شهرية أو أسبوعية، يصدر النظام تقريراً لكل طبيب يشمل:

- عدد الحجوزات المكتملة.
- إجمالي المبالغ المدفوعة.
- عمولة التطبيق.
- رسوم بوابة الدفع إن وجدت.
- صافي مستحقات الطبيب.
- المبالغ المعلقة.
- المبالغ المستردة.
- رقم عملية التحويل.
- تاريخ التسوية.
- التقييم الحالي.

9.4 سياسة الإلغاء والاسترداد

- فترة تعليق مدتها 48 ساعة بعد الموعد، وذلك لحماية الأطراف الثلاثة في حالات الإلغاء أو الشكاوى أو الخطأ.
- إذا ألغى المريض قبل 24 ساعة: استرداد كامل أو شبه كامل.
- إذا ألغى المريض متأخراً: يمكن خصم جزء من المبلغ.
- إذا ألغى الطبيب: استرداد كامل للمريض.
- إذا لم يحضر المريض: يمكن اعتبار جزء من العربون مستحقاً وفق السياسة.
- إذا حدث نزاع: تجميد المبلغ حتى مراجعة الحالة.
- يتم تطبيق سياسة استرداد مخصصة وفقاً لتقييم الطبيب، وذلك بناءً على الجدول التالي:

ملاحظات	مساهمة صندوق الضمان	حماية المريض المقترحة	الفئة
لا يرد النقد فوراً إلا للحالات الواضحة؛ الأفضل رصيد/إصلاح/تحويل.	6-8% من قيمة الحالة الكبيرة	حتى 100% رصيد علاجي أو إعادة علاج مشروطة بعد تحقق	A
حماية قوية لكن أقل من A.	4-6%	حتى 70%	B
مناسبة للحالات المتوسطة.	2-4%	حتى 50%	C
حماية محدودة.	1-2%	حتى 20%	D
يدفع للطبيب بسرعة أكبر لأنه خارج حماية المنصة.	0%	لا ضمان من المنصة	F

في حال أعلن الطبيب بوضوح عن فشل أو تعقيد طبي مثل كسر أداة، فشل زرع قبل التحميل، تعذر إكمال القلع، أو الحاجة لتحويل المريض إلى اختصاصي، فلا تُنشر الحالة ولا تدخل في التقييم الظاهر للمريض أو الجمهور. لكن يتم تسجيلها داخلياً ضمن مؤشر المضاعفات، ليس بهدف معاقبة الطبيب، بل لمنع إخفاء حالات الفشل وضمان شفافية النظام وجودة المتابعة. ويمكن اعتماد حدٍّ مبدئي للمضاعفات لا يتجاوز 10% في بداية التشغيل، على أن يتم لاحقاً تحديد نسب أدق بحسب نوع الخدمة وتصنيفها مع تراكم البيانات.

9.5 سياسة التسعير

لا تعتمد المنصة سعراً موحداً لجميع الأطباء، بل تحدد نطاقاً سعرياً مرناً يراعي نوع الخدمة، مستوى التصنيف العلمي، موقع العيادة، وتكاليف الطبيب التشغيلية. والهدف من ذلك ليس خفض الأسعار أو كسر السوق، بل تنظيم التسعير بطريقة عادلة تجعل السعر الأعلى مبرراً وواضحاً للمريض من خلال جودة الخدمة، التوثيق الطبي، والضمان.

ملاحظة	A	B	C	D	الخدمة
الأرقام النهائية تحدد بعد مسح المدينة؛ المثال السابق 800-900 B و 1200-1400 A يبقى نموذجاً تفاوضياً لا سعراً نهائياً.	نطاق أعلى مع حماية أقوى	نطاق مرتفع	نطاق متوسط	سعر منخفض بلا ضمان قوي	زرع سنوية واحدة
يشترط صور وأشعة ومطابقة الإطباق والحواف قدر الإمكان.	مرتفع جداً	مرتفع	متوسط	منخفض	تاج/تركيبية
ضمانه أضعف من الزراعات والتركيبات لأن الفشل البيولوجي أعلى.	مرتفع	متوسط مرتفع	متوسط	منخفض	علاج عصب
تستخدم كمدخل لاكتساب المريض، مع منع تحويل العلاج الكبير خارج التطبيق.	مرتفع نسبياً	متوسط	متوسط	منخفض	حشوة/تنظيف

10- مزاي التطبيق ووظائفه بحسب جهة الاستخدام

10.1 تطبيق المريض

- إنشاء حساب.
- حجز الموعد.
- تسجيل الدخول برقم الهاتف.
- الدفع الإلكتروني.
- اختيار المدينة والمنطقة.
- استلام تأكيد الحجز.
- البحث عن طبيب.
- تذكير بالموعد.
- فلاتر وفق الخدمة والسعر والموقع والتقييم.
- تقييم التجربة بعد الزيارة.
- صفحة طبيب تفصيلية.
- سجل الحجوزات.
- عرض المواعيد المتاحة.
- طلب دعم أو شكوى.

10.2 حساب الطبيب

- إنشاء حساب.
- استقبال الحجوزات.
- إدخال البيانات الشخصية والمهنية.
- قبول أو تعديل أو رفض الموعد وفق السياسة.
- رفع الوثائق المطلوبة.
- متابعة المدفوعات.
- إدخال موقع العيادة.
- متابعة الرصيد.
- تحديد ساعات العمل.
- الاطلاع على تقييمات المرضى.
- تحديد الخدمات والأسعار التقريبية.
- تحديث الملف.

10.3 لوحة تحكم خاصة بالإدارة

- إدارة الأطباء.
- إدارة التقييمات.
- التحقق من الوثائق.
- تقارير مالية.
- إدارة المرضى.
- تقارير تسويقية.
- إدارة الحجوزات.
- تقارير أداء الأطباء.
- إدارة المدفوعات.
- إدارة المحتوى والإشعارات.
- إدارة التسويات.
- إدارة المدن والمناطق والخدمات.
- إدارة الشكاوى.
- إدارة بانرات التطبيق وواجهته.

11- نظام تقييم الأطباء

يجب ألا يعتمد التطبيق على عبارة "أفضل طبيب" أو "الطبيب الأعلى كفاءة" بطريقة مباشرة، لأن ذلك قد يكون حساساً قانونياً ومهنياً. بدلاً من ذلك، تقترح الدراسة اعتماد نظامين:

11.1 نظام التصنيف العلني

لا يهدف التصنيف إلى الحكم على الطبيب شخصياً أو تقييمه اجتماعياً، بل إلى تصنيف الخدمة طبياً وتشغيلياً بناءً على معايير واضحة مثل التوثيق، الأدوات المستخدمة، الصور الشعاعية، ونتائج العلاج. ويُعرض هذا التصنيف للمريض بلغة مهنية تحفظ مكانة الطبيب وكرامته، بينما تبقى الرموز والمعايير التفصيلية واضحة داخلياً لإدارة المنصة بهدف المتابعة وضبط الجودة.

الأثر على السعر والضمان	الحد الأدنى المطلوب	الاسم العلني المقترح	الفئة الداخلية
أعلى نطاق سعري وأعلى حماية للمريض.	أشعة ذروية رقمية داخل العيادة، صور قبل/بعد، خطة علاج واضحة، نتائج موثقة، التزام عالٍ بالبروتوكول.	موثق ممتاز	A
نطاق سعري مرتفع متوسط وضمان قوي لكن أقل من A.	توثيق جيد جداً مع بعض النواقص غير الجوهرية، خبرة واضحة، ونسبة نزاعات منخفضة.	موثق متقدم	B
سعر متوسط وضمان محدود.	توثيق مقبول وحد أدنى علمي،	موثق أساسي	C
سعر منخفض وضمان محدود جداً.	توثيق ضعيف لكنه لا يزال قابلاً للإدخال في بعض الخدمات البسيطة.	توثيق محدود	D
لا ضمان من المنصة ولا تسعير مرتفع ولا وصول مباشر لقناة المؤسس إلا استثناء.	لا يملك أشعة ذروية رقمية داخل العيادة أو لا يلتزم بالتوثيق المطلوب.	غير مشمول بحماية المنصة	F

11.2 التقييم الاجتماعي

يعتمد على عناصر غير تشخيصية يحددها المرضى والمراجعون، مثل:

- الالتزام بالموعد.
- النظافة العامة.
- التعامل والاحترام.
- وضوح التكلفة.
- سهولة الوصول.
- الرضا العام عن التجربة.

12- الخطة التقنية

12.1 المكونات التقنية

- تطبيق مريض لنظام Android.
- تطبيق مريض لنظام iOS.
- لوحة طبيب Web أو تطبيق طبيب مبسط.
- لوحة إدارة مركزية Web.
- Backend API.
- قاعدة بيانات.
- نظام إشعارات.
- نظام دفع إلكتروني.
- نظام إدارة حجوزات.
- نظام تقييمات معتمد على الذكاء الاصطناعي.
- نظام تقارير مالية.
- نظام صلاحيات للمستخدمين.

12.2 الدفع الإلكتروني

يجب تصميم طبقة الدفع بشكل مستقل، بحيث يمكن ربط:

- منصة شام كاش.
- مزود دفع محلي آخر.
- بوابات مستقبلية مثل Visa/Mastercard عند تفعيلها عملياً.
- تحويلات داخلية أو محافظ إلكترونية أخرى.

12.3 الأمان وحماية البيانات

بسبب حساسية القطاع الصحي، يجب تطبيق:

- تشفير الاتصال. HTTPS
- تشفير البيانات الحساسة.
- عدم تخزين أي كلمات مرور أو رموز دفع حساسة.
- صلاحيات محددة لكل مستخدم.
- سجلات دخول وتعديل.
- نسخ احتياطي دوري.
- حماية من محاولات الاختراق.
- مراجعة أمنية قبل الإطلاق.
- سياسة خصوصية واضحة.
- موافقة صريحة من المستخدمين على معالجة بياناتهم.

12.4 الاستضافة

يمكن البدء باستضافة سحابية موثوقة ومرنة، مع مراعاة:

- قوانين استضافة بيانات المستخدمين.
- سرعة الوصول من سوريا.
- تكاليف التشغيل.
- استمرارية الخدمة.
- النسخ الاحتياطي.
- الحماية من توقف الخدمة.

13- الدراسة القانونية والتنظيمية

13.1 الشكل القانوني المقترح

ينصح بتأسيس المشروع كشركة محدودة المسؤولية داخل سوريا، وذلك للأسباب التالية:

- تسهيل فتح حسابات بنكية تجارية.
- تسهيل التعاقد مع مزودي الدفع.
- تسهيل التعاقد مع الأطباء.
- إعطاء ثقة أكبر للمستخدمين والشركاء.
- حماية أفضل عند التوسع أو دخول مستثمرين لاحقاً.

13.2 غرض الشركة

يجب صياغة غرض الشركة بعناية في النظام الأساسي بحيث يشمل:

- خدمات الوساطة الرقمية بين مقدمي الخدمات والعملاء.
- التقييم العلمي الموضوعي للأطباء.
- إدارة المدفوعات من خلال مزودي دفع مرخصين.
- خدمات تقنية ومعلوماتية.
- أي نشاط آخر يسمح به القانون ومرتببط بالتطبيق.
- يجب تجنب صياغة غرض الشركة وكأنها تقدم علاجاً طبياً مباشراً، لأن التطبيق لا يقدم العلاج، بل يربط المرضى بأطباء مستقلين.

13.3 العلاقة القانونية مع الأطباء

يجب توقيع اتفاقية استخدام أو عقد تعاون مع كل طبيب، يتضمن:

- أن الطبيب مستقل وليس موظفاً لدى التطبيق.
- أن الطبيب مسؤول عن التشخيص والعلاج.
- أن التطبيق مسؤول عن الحجز والدفع وتنظيم التجربة فقط.
- نسبة التطبيق واشتراكات الأطباء وفق كل فئة تصنيف.
- آلية التسوية.
- سياسة الإلغاء.
- سياسة الشكاوى.
- ضوابط استخدام التقييمات.
- منع تقديم معلومات مضللة.
- التزام الطبيب بتحديث بياناته.
- موافقة الطبيب على ظهور بياناته داخل التطبيق.

13.4 العلاقة القانونية مع المرضى

يجب أن يوافق المريض على:

- شروط الاستخدام.
- سياسة الخصوصية.
- سياسة الدفع والاسترداد.
- أن التطبيق لا يقدم استشارة طبية مباشرة.
- أن اختيار الطبيب مسؤولية المستخدم بناءً على البيانات المعروضة.
- أن التقييم يجب أن يكون صادقاً وغير تشهيري.
- أن أي شكوى طبية جوهرية تخضع للجهات المختصة.

13.5 حماية الفكرة والعلامة التجارية

يجب حماية اسم التطبيق وشعاره قانونياً قبل الإطلاق الواسع.

الخطوات المقترحة:

- اختيار اسم عربي وإنجليزي قابلين للتسجيل.
- البحث المسبق عن العلامات المشابهة.
- حجز النطاق الإلكتروني.
- حجز حسابات التواصل الاجتماعي.
- تسجيل العلامة التجارية في سوريا.
- تسجيل الشعار.
- دراسة تسجيل العلامة لاحقاً في أسواق أخرى إذا توسع المشروع.

13.6 مكافحة التحايل خارج التطبيق

- يجب التعامل مع احتمال خروج الطبيب أو المريض خارج التطبيق باعتباره خطراً متوقعاً، لا حالة استثنائية. لذلك ينبغي تصميم النظام منذ البداية بحيث يصبح التعامل خارج المنصة غير مريح وغير مجدٍ للطرفين.

- أي مبلغ يُدفع خارج المنصة لا تشمله سياسة الضمان، ولا يترتب عليه تحكيم، أو رصيد علاجي، أو تحويل إلى طبيب بديل.
- في حال ظهرت حاجة لعلاج جديد بعد الكشف أو الحشوة أو التنظيف، يجب إدخالها عبر خيار Treatment Upgrade خلال 24 ساعة، مع موافقة المريض وإتمام الدفع داخل التطبيق.
- لا يتحسن تصنيف الطبيب ولا تظهر حالاته العلمية داخل المنصة إلا من خلال الحالات المدفوعة والموثقة بالكامل عبر التطبيق.
- يتم التواصل شهرياً مع عينة عشوائية من المرضى للتأكد من عدم وجود دفع خارجي أو اتفاق جانبي بين الطبيب والمريض.
- من الضروري تعيين موظف مختص بمتابعة المرضى وكشف محاولات التحايل منذ البداية، لأن هذا الدور يحمي الإيرادات والثقة، ولا يقتصر على خدمة العملاء فقط.
- يمكن منح المريض حافزاً عند الإبلاغ عن طلب دفع خارجي، مثل رصيد داخل التطبيق أو خصم على خدمة لاحقة، في حال ثبوت المخالفة.
- تبدأ العقوبات بإنذار أول، ثم خفض التصنيف والظهور، ثم خصم من المستحقات المحتجزة، وصولاً إلى تعليق الحساب أو الطرد عند تكرار المخالفة.
- عند تعليق أو طرد الطبيب، يُنشر سبب عام ومحاييد مثل: (تم تعليق الحساب بسبب مخالفة سياسة الدفع أو التوثيق أو الضمان) دون نشر تفاصيل اتهامية قد تفتح باب التشهير إلا بعد استشارة قانونية.

13.7 مكافحة التقليد والاستنساخ

- في السوق الشعبي، من الطبيعي أن تظهر محاولات لتقليد الفكرة إذا نجحت، لذلك لا يكفي الاعتماد على الحماية القانونية وحدها، بل يجب بناء دفاع متكامل حول المشروع.
- يجب أن تقوم قوة المنصة على مجموعة عناصر مترابطة تشمل العلامة التجارية، قاعدة الأطباء، نظام الضمان، البيانات، العلاقة مع المؤسس، وسرعة التنفيذ.
- يجب تسجيل الاسم والشعار والعلامة التجارية في سوريا منذ البداية، ثم في الأسواق المستهدفة لاحقاً مثل الخليج أو تركيا عند التفكير بالتوسع.
- ينبغي حجز النطاقات وحسابات السوشيال ميديا للأسماء الأساسية والبديلة، لمنع استغلالها أو تقليدها لاحقاً.
- يجب أن تكون ملكية الكود، قاعدة البيانات، حسابات المتاجر، والسيرفرات باسم الشركة أو المؤسس، وليس باسم المدير أو شركة التطوير.
- يجب توقيع عقود سرية وتنازل عن حقوق الملكية الفكرية مع كل مطور أو موظف أو مندوب يعمل على المشروع.
- لا تُكشف أوزان التصنيف الكاملة للأطباء أو الموظفين؛ يمكن إعلان المعايير العامة فقط، بينما تبقى التفاصيل الدقيقة سرية تجارية.
- يتم وضع علامة مائية داخلية على الصور والتقارير، مع تسجيل وقت رفعها ومصدرها، للحد من نسخ الحالات أو استخدامها خارج المنصة.
- يجب استثمار خطة Founding Doctor لبناء ولاء أول 300 طبيب، عبر مزايا يصعب على أي مقلد تقديمها بسرعة.
- أي تطبيق مقلد لا يملك نظام ضمان، أو صندوق حماية، أو مؤسساً بخبرة سريرية واضحة، سيبقى مجرد دليل أطباء، لا منصة جودة طبية موثوقة.

13.8 قناة الاتصال المباشر مع الدكتور عبد الرحمن الأغا

لمنع احتكار المعلومات من قبل الإدارة، وتعزيز شعور الأطباء بالاحترام، يتم تخصيص رقم واتساب مستقل للأطباء المصنفين ضمن الفئات A/B/C/D للتواصل النصي المباشر مع الدكتور عبد الرحمن الأغا، على أن تكون هذه القناة منظمة ومجدولة، وليست وسيلة تواصل عشوائية أو مفتوحة دائماً. ولا تُمنح هذه القناة لأطباء الفئة F إلا بقرار خاص. وتهدف القناة إلى استقبال اعتراضات الأطباء، ملاحظات الجودة، الشكاوى من سوء الإدارة، ومقترحات تطوير البروتوكولات. كما يجب توثيق كل تواصل مهم ضمن سجل إداري رسمي، حتى لا يتحول التواصل الشخصي إلى باب للوساطة أو الضغط الاجتماعي. ويُفضل استخدام اسم Professor Sam Wise بدلاً من الاسم العربي الحقيقي للدكتور عبد الرحمن، لتجنب الإحراج والوساطات المحلية، وللحفاظ على الاحترام المهني والموقع العلمي للمؤسس داخل المنصة.

14- مراحل تنفيذ المشروع

المرحلة الأولى: التحليل والتحضير

- تثبيت نموذج العمل.
- تحديد اسم مبدئي للتطبيق.
- تصميم وبناء العلامة التجارية ومنصاتها.
- تحديد نموذج الدفع.
- وضع نموذج العقود الأولية.
- تحديد خطة جمع بيانات الأطباء.

المرحلة الثانية: الإجراءات القانونية

- ترخيص المشروع كشركة محدودة المسؤولية.
- إجراءات حماية العلامة التجارية.

المرحلة الثالثة: تشكيل الفريق

- البحث عن مندوبين ملائمين لتمثيل المشروع.
- اسناد كافة مهام التنفيذ لأفراد فريق أفق.

المرحلة الرابعة: جمع بيانات الأطباء في حلب

- قاعدة بيانات أولية.
- تصنيف الأطباء حسب المنطقة والخدمة.
- التوصل مع الأطباء.
- توثيق الحسابات.
- تصوير أو جمع صور العيادات عند الإمكان.
- تدريب الأطباء الأوائل على استخدام المنصة.

المرحلة الخامسة: الهوية وتجربة المستخدم

- تصميم تجربة المستخدم.
- واجهات المريض.
- واجهات الطبيب.
- لوحة الإدارة.

المرحلة السادسة: التطوير التقني

- تطبيق المريض.
- لوحة الطبيب.
- لوحة الإدارة.
- قاعدة البيانات.
- نظام الحجز.
- نظام الدفع.
- نظام التقييم.
- نظام التسوية المالية.
- الإشعارات.
- التقارير الأساسية.

المرحلة السابعة: الاختبار المغلق

- تجربة مع مجموعة أطباء محدودة.
- تجربة مع مستخدمين حقيقيين.
- اختبار الدفع.
- اختبار الإلغاء والاسترداد.
- اختبار التقييمات.
- إصلاح الأخطاء.

المرحلة الثامنة: الإطلاق التجريبي في حلب

- حملة إطلاق محدودة.
- دعم مباشر للأطباء.
- مراقبة الحجوزات.
- متابعة الشكاوى.
- تحسينات مستمرة.
- قياس مؤشرات الأداء.

المرحلة التاسعة: الإطلاق الرسمي

- حملة تسويقية أوسع.
- توسع في عدد الأطباء.
- إضافة خدمات جديدة.
- تحسين نظام الدفع.
- زيادة الوعي بالعلامة التجارية.
- بناء شراكات محلية.

المرحلة العاشرة: التوسع

- نقل التجربة بكافة إجراءاتها إلى مدينة أخرى.
- الانتقال إلى تخصصات طبية أخرى.

المخاطر الرئيسية عبر مراحل التأسيس والتنفيذ

الخطر	مستوى الخطر	الحل
تحايل الطبيب والمريض خارج التطبيق	عالي جداً	عمولة أقل، اشتراك تدريجي، ضمان مشروط، تدقيق عشوائي، حجز مستحقات، عقوبات واضحة.
تضخم الرواتب	عالي	فريق صغير ورواتب محلية، لا طبيب مراجع في البداية، مندوبي مبيعات بالقطعة.
الضمان يصبح خسارة	عالي	صندوق منفصل، ضمان مشروط، لا نقد فوري، ضبط النسب بعد أول 300-500 حالة.
عداء الأطباء	متوسط-عالي	خطاب ترقية السوق، أسماء علنية محترمة، قناة مباشرة مع Professor Sam Wise للفئات غير F.
خطر اسم Ubertib	متوسط-عالي	بحث علامة رسمي قبل التسويق الكبير، شعار لا يشبه Uber، اسم بديل جاهز.
تقليد التطبيق	عالي	تسجيل العلامة، ملكية البيانات والكود، سرعة بناء الشبكة، حماية الخوارزمية والضمان.
فشل المدير أو سفره	متوسط	عقد سنتين، مؤشرات أداء، مهلة علاج، حق تعيين قائم بالأعمال، إنهاء عند الفشل.

15- الجدول الزمني لمراحل المشروع

ستمتد الفترة الزمنية لكافة مراحل المشروع منذ التأسيس حتى التوسع عبر 12 شهراً مفصلة وفق نموذج Gantt التالي:

الشهر 12	الشهر 11	الشهر 10	الشهر 9	الشهر 8	الشهر 7	الشهر 6	الشهر 5	الشهر 4	الشهر 3	الشهر 2	الشهر 1	
												التحليل والتحضير
												الإجراءات القانونية
												تشكيل الفريق
												جمع بيانات الأطباء في حلب
												الهوية وتجربة المستخدم
												التطوير التقني
												الاختبار المغلق
												الإطلاق التجريبي في حلب
												الإطلاق الرسمي
												التوسع

16- الكادر البشري المطلوب

16.1 فريق العمليات

- مسؤول مالي.
- مسؤول إدارة لوحة تحكم التطبيق.
- مسؤول علاقات أطباء ميداني.
- موظف جمع بيانات وتوثيق.
- موظف دعم أطباء.
- موظف خدمة عملاء.

16.2 الفريق التقني

- Business Analyst.
- UI/UX Designer.
- Mobile Developer.
- Backend Developer.
- Web/Admin Developer.
- DevOps/Security Specialist.

16.3 فريق التسويق

- مدير تسويق.
- مسؤول إعلانات رقمية.
- صانع محتوى.
- مصمم غرافيك.

17- الخطة التسويقية الأولية

17.1 مرحلة ما قبل الإطلاق

الأهداف:

- ضم عدد جيد من الأطباء.
- بناء ثقة أولية.
- تجهيز المحتوى.
- إطلاق صفحات التواصل.
- شرح فكرة التطبيق.
- جمع قائمة انتظار من المستخدمين.

الأدوات:

- زيارات ميدانية للأطباء.
- شرح شروك التسجيل ومميزاته.
- تصوير ملفات الأطباء.
- منح شارة "طبيب موثق".
- حملات تعريفية على فيسبوك وإنستغرام.
- التعاون مع صفحات محلية في حلب.

17.2 مرحلة الإطلاق التجريبي

الأهداف:

- تحقيق أول حجوزات فعلية.
- اختبار الدفع.
- جمع تقييمات حقيقية.
- تحسين تجربة الاستخدام.

الأدوات:

- خصومات على أول حجز.
- كوبونات ترحيبية.
- حملة "احجز طبيب أسنانك بسهولة".
- فيديوهات شرح قصيرة.
- منشورات توعوية حول اختيار الطبيب.
- دعم مباشر عبر واتساب أو داخل التطبيق.

17.3 مرحلة الإطلاق الرسمي

الأهداف:

- الانتشار في حلب.
- زيادة عدد الحجوزات.
- زيادة ثقة المرضى.
- رفع عدد الأطباء المسجلين.

القنوات:

- إعلانات فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
- Google Search عند توفره وفعاليته محلياً.
- شراكات مع صيدليات.
- شراكات مع مخابر أسنان.
- منشورات توعوية.
- محتوى فيديو.
- مؤثرون محليون.
- إحالات المستخدمين.

17.4 برنامج الإحالات

- المريض الذي يدعو صديقاً يحصل على رصيد.
- الطبيب الذي يدعو طبيباً آخر يحصل على ظهور مميز لفترة محدودة.
- العيادات التي تجلب حجوزات أكثر تحصل على شارة نشاط.

17.5 برنامج التوعية والتعليم المجتمعي

لا يقتصر المشروع على بيع موعد طبي، بل يقدم ثقافة جديدة في اختيار طبيب الأسنان، تقوم على التوثيق العلمي، الضمان، والشفافية. لذلك يجب أن يكون الاستثمار التسويقي في البداية موجهاً لبناء وعي المريض، لا لمجرد الترويج للحجز. وترتكز الرسالة الأساسية على أن السعر الأعلى لا يكون مبرراً إلا عندما تقابله خدمة موثقة علمياً ومحمية بضمان مكتوب.

ولتحقيق ذلك، يجب أن تعتمد المنصة على محتوى توعوي وتسويقي يشرح الفرق بين الطبيب المشهور والطبيب الموثق، ويؤكد أهمية الدفع داخل التطبيق للحصول على الضمان، مع عرض حالات قبل وبعد موافقة المرضى وإخفاء هوياتهم.

كما يجب توضيح أن وجود الأشعة الرقمية داخل العيادة ليس رفاهية، بل جزء من الحد الأدنى للطب الموثق، مع تقديم خطاب خاص للمغتربين والسياحة العلاجية يركز على السعر الواضح، الطبيب المصنف، الملف الطبي الموثق، والحماية المكتوبة. وفي المرحلة الأولى، يجب تجنب مهاجمة الأطباء أو فضح السوق، وأن يكون الخطاب العام قائماً على تطوير جودة السوق ورفع معاييرها، لا على الصدام أو التشهير.

كما يمكن تأسيس منصة بودكاست خاصة بالمشروع تستضيف أطباء وخبراء في هذا المجال لمناقشة أهم المواضيع الطبية ذات الصلة ولرفع الوعي لدى الجمهور بالمشروع وبالمواضيع الطبية ذات الصلة.

18- التوصية النهائية

المشروع قابل للتنفيذ، ويحمل فرصة جيدة إذا تم التعامل معه كمنصة ثقة وتشغيل وتقييم، وليس كتطبيق برمجي فقط.

عوامل النجاح الأساسية هي:

1. جمع قاعدة بيانات حقيقية وموثقة لأطباء الأسنان في حلب.
 2. بناء نظام دفع وتسوية واضح.
 3. تسجيل الأطباء لتسريع الانتشار.
 4. بناء نموذج ربح من عمولة محددة على كل عملية.
 5. حماية العلامة التجارية وتأسيس شركة نظامية.
 6. تجنب الادعاءات الطبية الحساسة.
 7. إطلاق تجريبي مضبوط قبل الإطلاق الرسمي.
 8. توفير دعم عملاء قوي.
 9. بناء الثقة تدريجياً لدى المرضى والأطباء.
- التوصية العملية هي البدء بمرحلة تحضيرية مدتها شهر واحد، يتم خلالها:
- اختيار الاسم المناسب والنهائي للتطبيق.
 - بناء قائمة أولية من أطباء حلب ومسح عام للسوق.
 - إعداد الصيغة النهائية لخريطة التطبيق، مع تصور عام عن رحلة المستخدم.
 - البدء بالعمل على التراخيص والوثبوتيات الرسمية اللازمة.

مع أطيب الأمنيات بالتوفيق